

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: Camilo Enrique Carreño Saucedo	H.C: 1066892646
EDAD: 8 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 7/07/2017
ESCOLARIDAD: Segundo	FECHA DE EVALUACIÓN: 7/23/07/2025
DIRECCION: Manzana 69 casa 8 B	CORREO: masaum2@hotmail.com
EPS: Particular	SEXO: M
ACOMPANANTE: Padres	CELULAR: 3185230042
LATERALIDAD: Diestra	NEUROPSICÓLOGO EVALUADOR: M.G Jainer Guzmán Vega.
ESPECIALIDAD QUE REMITE: NA	

MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, “desde muy niño ha tenido pataletas, cuando va a estudiar es muy difícil, se le olvidan las cosas”.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde el grado transición caracterizado por hacer pataletas, berrinches todo lo quiero tirar y dañar, terquedad, fijaciones en algunos aspecto – poco flexible, se le olvida donde deja las cosas y lo que va hacer, se le debe dar varias veces las instrucciones, le cuesta prestar atención, poca motivación escolar, se queda en dictado, se cansa con facilidad, baja motivación escolar, se distrae con facilidad, lo sientas detrás por ser muy alto, prefiere hacer otra cosa que hacer las tareas, necesidad de apoyo y supervisión para hacer tareas, en ocasiones se levanta con pesadillas, eso sucede desde los tres años, ha disminuido pero aún persiste.

Buen aprendizaje, esta aprendiendo a leer, lo hace bien aunque no fluido, en ocasiones se levanta del puesto, toma las cosas en ocasiones sin consentimiento, dislalia – rotacismo, en ocasiones cuando va a hablar se bloque como si fuera disfemico.

I. HISTORIA PERSONAL

PRENATALES: 2 embarazo previo, asistió a controles, embarazo sin riesgo, madre y padre no toman licor, no cigarrillo, no alucinógenos, adecuada alimentación, no auto medicación, no golpe abdominal o caída, no alteraciones en estado de ánimo, no enfermedades médicas.

PERINATALES: Embarazo a término de 36.2 semanas de gestación por cesárea, (no) utilización de fórceps, (no) maduración de pulmones en el útero, (no) hipoxia perinatal, no cianosis, (no) meconio, (no) sufrimiento fetal, (no) permaneció en incubadora.



II. DESARROLLO PSICOMOTOR

POSNATALES: Control cefálico 3 meses, rolado 3 meses, sentado 6 meses, gateo a los 7 meses, patrón recíproco, bipedestación 11 meses, marcha 12 meses, (si) reacción a los sonidos, (si) fijación de la mirada, lenguaje no funcional, reporte peso al nacer 3600 kg, reporte de talla 51 – 55 cm.

III. DESARROLLO DEL LENGUAJE

Balbuceo: 8 meses
Primeras palabras: 11 meses
Frases: 18 meses.
Oraciones: 24+ meses.

IV. ABC

Come solo: 12 meses
Se baña solo: 4 – 5 años.
Se viste solo: 4 años.
Higiene personal: 4 años.
Control de esfínteres: 5 años.

V. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta
Alcoholismo: No reporta
Drogadicción: No reporta
Epilepsia: No reporta
Autismo: Primo materno con autismo
TDAH: No reporta
Esquizofrenia: No reporta

VI. ANTECEDENTES PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: NO REPORTA.
Quirúrgicos: NO.
Tóxicos: NO.
Hospitalizaciones: NO.
Inmunizaciones: Si.

VII. HISTORIA DEL DESARROLLO

MOTOR: Normal.
LENGUAJE: Fluido.
ADAPTATIVO: Normal.



Comunicación, lenguaje y conversación concretos e inmaduros (no), Dificultad en la regulación de las emociones y el comportamiento (no), comprensión limitado del riesgo en situaciones sociales (si), juicio social inmaduro (no), es fácilmente manipulado por otros (?). [1/6]

(No) Dependencia en las actividades de la vida diaria.

VIII. HISTORIA ESCOLAR

Paciente quien cursa segundo grado, ocupó el puesto 12 de un total de 34, quejas escolares por ser distraído, tardaba mucho o se quedaba para la escritura - dictado, tiene un grupo con el que interactúa por el cual se desconcentra, se levanta del puesto de trabajo en algunas ocasiones.

IX. HISTORIA SOCIOAFECTIVA

Inicia, mantiene y finaliza una interacción con otros. (si)
Reconoce sentimientos. (si)
Regular su propia conducta. (no)
Controla sus impulsos. (no)
Hace y mantiene relaciones de amistad y amor. (si)
Se comporta en público de manera socialmente aceptable. (si)
Termina las actividades que inicia. (si)
Acepta los límites del adulto. (si)
Cumple con normas de cortesía: por favor, gracias, permiso (si)
Resuelve problemas y situaciones cotidianas. (si)
Respeto los reglamentos deportivos y recreativos (si)
Realiza trabajos sin depender de otros. (si)

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, adecuada higiene postural, orientado a lo y auto psíquicamente, taquilalia, taquipsiquia, logorrea, distractivo, no alteraciones de sueño, no alteraciones o quejas de memoria, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conciencia.

PRUEBAS APLICADAS

Se realizó prueba cognitiva Escala de inteligencia de Wechsler para niños V: Atención, Claves del Wisc V, Búsqueda de símbolos del Wisc V: Memoria: Dígitos del Wisc V dígitos en orden directo, inverso y creciente, Span de dibujos del Wisc V, Lenguaje: Semejanzas del Wisc V, Vocabulario.



Se realizó evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas y atención: Función Ejecutiva, (Wisconsin, token test, stroop, fluidez semántica y fonológica, TMT A – B, test de caras), lista de chequeo TDAH, TDAH 5.

Evaluación Neuropsicológica

Cuestionario Check list NEUROPSI 2		
Criterios DSM 5	A1 Inatento (7) Alterado	A2 Hiperactividad/Impulsividad (2) Normal
Observación: Las puntuaciones superiores en la escala clínica a 5 puntos, son consideradas en riesgo, y una puntuación iguales o superiores a 6 puntos en la escala adaptativa se consideran un criterio de anormalidad		



PRASCA
CENTER

ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS (WISC V)

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada





ESCALA DE INTELIGENCIA
DE WECHLER PARA NIÑOS - V

Cuadernillo de anotación

Cálculo de la
edad
cronológica

Año Mes Día

Fecha de aplicación

Fecha de nacimiento

Edad Cronológica

2025 7 9

2017 7 7

8 0 2

Nombre del niño:

Camilo Enrique Carreño Saucedo

Examinador:

JAINER GUZMÁN VEGA

Página de resumen

Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares

Prueba	PD	Puntuación escalar					
Cubos	14		7				7
Semejanzas	23	9					9
Matrices	8			5			5
Dígitos	15				6		6
Claves	18					4	4
Vocabulario	16	6					6
Balanzas	14			8			8
Puzles visuales	10		8				(8)
Spam de dibujos	22				9		(9)
Búsqueda de Símbolos	15					7	(7)
Información							(1)
Letras y números	16						(11)
Cancelación							(1)
Comprensión							(1)
Aritmética	16						(10)
Suma puntuaciones escalares		15	15	13	15	11	45
		Comp. Verbal	Visoes-pacial	Razon. Fluido	Mem. Trabajo	Vel. Proces.	Escala total

Perfil de puntuaciones escalares

	Comprensión verbal				visoes-pacial		Razonamiento fluido			Memoria de Trabajo			Velocidad de Procesamiento		
	S	V	I	CO	C	PV	M	B	A	D	SD	LN	CL	BS	CA
	9	6	1	1	7	8	5	8	10	6	9	11	4	7	1
19															
18															
17															
16															
15															
14															
13															
12															
11															
10															
9															
8															
7															
6															
5															
4															
3															
2															
1															

Perfil de puntuaciones compuestas

	ICV	IVE	IRF	IMT	IVP	CIT
	86	86	79	85	75	75
160						
155						
150						
145						
140						
135						
130						
125						
120						
115						
110						
105						
100						
95						
90						
85						
80						
75						
70						
65						
60						
55						
50						
45						
40						

Conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas

Escala	Suma punt. escalares	Puntuación compuesta		Rango Percentil	Intervalo de confianza
					95%
Comprensión Verbal	15	ICV	86	18	79-96
Visoespacial	15	IVE	86	18	79-96
Razonamiento fluido	13	IRF	79	8	73-88
Memoria de trabajo	15	IMT	85	16	79-96
Velocidad de procesamiento	11	IVP	75	5	69-87
Escala total	45	CIT	75	5	70-82

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

Análisis Primario

Puntos fuertes y débiles						Punto fuerte o débil
		Puntuación	Puntuación de comparación	Diferencia	Valor crítico	
Indices	ICV	86	- 82,2	= 3,8	10,9	F o D
	IVE	86	- 82,2	= 3,8	9,07	F o D
	IRF	79	- 82,2	= -3,2	9,07	F o D
	IMT	85	- 82,2	= 2,8	8,67	F o D
	IVP	75	- 82,2	= -7,2	11,22	F o D
Pruebas	Semejanzas	9	- 6,9	= 2,1	3,16	F o D
	Vocabulario	6	- 6,9	= -0,9	3,44	F o D
	Cubos	7	- 6,9	= 0,1	3,16	F o D
	Puzles visuales	8	- 6,9	= 1,1	2,17	F o D
	Matrices	5	- 6,9	= -1,9	2,66	F o D
	Balanzas	8	- 6,9	= 1,1	2,05	F o D
	Dígitos	6	- 6,9	= -0,9	2,38	F o D
	Span de dibujos	9	- 6,9	= 2,1	2,38	F o D
	Claves	4	- 6,9	= -2,9	3,29	F o D
	Búsqueda de símbolos	7	- 6,9	= 0,1	3,22	F o D



Opciones de comparación de los índices

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones de los 5 índices primarios

MIP

411

/ 5

82,2

Nivel de significación del valor crítico

Opciones de comparación de las pruebas

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones escalares de las 10 pruebas principales

MPE-P

69

/ 10

6,9

Comparación entre índices/pruebas

Comparación		Puntuación 1	Puntuación 2	Diferencia	Valor crítico	Diferencia significativa
Indices	ICV-IVE	ICV 86	- IVE 86	= 0	11,27	S o N
	ICV-IRF	ICV 86	- IRF 79	= 7	11,27	S o N
	ICV-IMT	ICV 86	- IMT 85	= 1	11,00	S o N
	ICV-IVP	ICV 86	- IVP 75	= 11	12,78	S o N
	IVE-IRF	IVE 86	- IRF 79	= 7	9,83	S o N
	IVE-IMT	IVE 86	- IMT 85	= 1	9,53	S o N
	IVE-IVP	IVE 86	- IVP 75	= 11	11,53	S o N
	IRF-IMT	IRF 79	- IMT 85	= -6	9,53	S o N
	IRF-IVP	IRF 79	- IVP 75	= 4	11,53	S o N
	IMT-IVP	IMT 85	- IVP 75	= 10	11,27	S o N
Pruebas	Semejanzas-	S 9	- V 6	= 1	2,93	S o N
	Vocabulario-	C 7	- PV 8	= -1	2,77	S o N
	Cubos-	M 5	- B 8	= -3	2,29	S o N
	Matrices-	D 6	- SD 9	= -3	2,48	S o N
	Balanzas-	CL 4	- BS 7	= -3	3,04	S o N
	Dígitos-					
	Span de dibujos-					
	Claves-					
	Búsqueda de símbolos					

Opciones de comparación de los índices

Nivel de significación del valor crítico

Grupo de referencia

Nivel de aptitud

Opciones de comparación de las pruebas

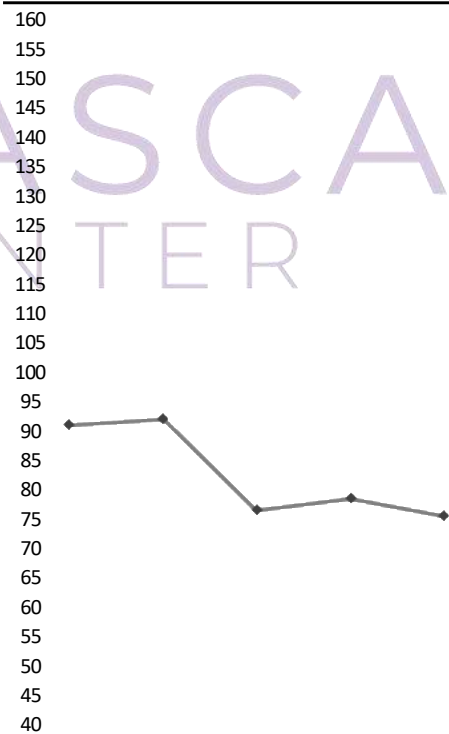
Nivel de significación del valor crítico



Análisis Secundario					
Suma de puntuaciones escalares					
Pruebas	Puntuación escalar				
Cubos			7	7	
Semejanzas				9	
Matrices			5	5	
Dígitos		6			6
Claves			4		4
Vocabulario				6	
Balanzas	8		8	8	
Puzles visuales			8		
Span de dibujos			9		9
Búsqueda de símbolos					7
Letras y números		11			
Aritmética	10				
Suma de puntuaciones escalares	18	17	41	35	26

Raz. Cuantitativo Mem. Trabajo auditivo No verbal Capacidad General Competencia Cognitiva

IRC	IMTA	INV	ICG	ICC
91	92	77	79	76



Conversión de suma de puntuaciones escalares a índices					
Escala	Suma puntuaciones escalares	Índice		Rango Percentil	Intervalo de confianza 95%
Razonamiento Cuantitativo	17	IRC	91	27	84-99
Memoria de trabajo auditiva	17	IMTA	92	30	85-99
No verbal	41	INV	77	6	72-84
Capacidad general	35	ICG	79	8	73-87
Competencia cognitiva	26	ICC	76	5	70-86

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. El paciente obtuvo un CIT de **75**, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **86**, se clasifica como **capacidad media baja**, estando en 1 rango por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **86**, se clasifica como **capacidad media baja**, estando en 1 rango por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos construccionales, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Razonamiento fluido

El valor obtenido es de **79**, se clasifica con una capacidad general **inferior**, ubicándolo dos rangos por debajo del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Este índice mide la capacidad cognitiva innata del paciente para procesar nueva información, relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento inductivo y cuantitativo a fin de identificar y aplicar reglas.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **85**, se clasifica como **capacidad media baja**, estando en 1 rango por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental; aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente.

Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **75**, se clasifica con una capacidad general **inferior**, ubicándolo dos rangos por debajo del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para aparear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.



INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES SECUNDARIOS

Razonamiento cuantitativo

El valor obtenido en IRC de 91 (entre 84-99) se sitúa en el percentil 27, se clasifica como punto fuerte normativo / Normal con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de Razonamiento cuantitativo refleja la capacidad para realizar operaciones matemáticas mentalmente y comprender las relaciones cuantitativas. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió resolver mentalmente problemas aritméticos (Aritmética, Pe = 10) y en la otra se le pidió que observe una balanza a la cual le faltan pesas y seleccionar la opción que la mantiene equilibrada (Balanzas, Pe = 8). La variabilidad de los resultados en estas tareas es representativa/ no representativa (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

Memoria de trabajo auditiva

El valor obtenido en IMTA de 92 (entre 85-99) se sitúa en el percentil 30 y se clasifica como Promedio / Normal, con relación a otros niños de su edad y edad escolar.

El índice de Memoria de trabajo auditiva indica la aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió repetir una lista de cifras en el mismo orden o en orden inverso (Dígitos, Pe = 6) y en la otra se le solicitó repetir una combinación de letras y números leída previamente por el/la entrevistador/a (Letras y números, Pe = 11). La diferencia de los resultados entre las dos tareas es significativa (por encima de los 5 puntos), aunque el resultado en IMTA es una buena medida de memoria de trabajo auditiva pueden existir dificultades en caso de que se requiere un alto grado alto de respuesta efectiva, mantenimiento de la información en línea, la diferencia en memoria de trabajo 85 y memoria de trabajo auditiva se da debido a que el paciente pudo compensar las dificultades con las puntuaciones positiva en letras y números.

No verbal

El valor obtenido en INV de 77 (entre 72-84) se sitúa en el percentil 6 y se clasifica como Punto débil normativo / Bajo con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice no verbal puede interpretarse como una medida de aptitud intelectual general que reduce al mínimo la intervención del lenguaje expresivo. El INV está conformado por 6 puntuaciones escalares de pruebas que no requieren respuestas verbales: cubos (Pe = 7), matrices (Pe = 5), claves (Pe = 4), balanzas (Pe = 8), puzles visuales (Pe = 8) y span de dibujos (Pe = 9). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos aunque no en todas las tareas), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

Capacidad general

El valor obtenido en ICG de 79 (entre 73-87) se sitúa en el percentil 8 y se clasifica como Punto débil normativo / Bajo con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice de capacidad general hace referencia a una estimación de la aptitud intelectual general menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento que el CI total. Involucra la capacidad de razonamiento abstracto y conceptual, razonamiento visoperceptivo y



espacial y resolución de problemas verbales. El ICG es el resultado de 5 puntuaciones escalares: cubos (Pe = 7), semejanzas (Pe = 9), matrices (Pe = 5), vocabulario (Pe = 6) y balanzas (Pe = 8). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud no es mayor a 5 puntos), pero el indicador general está por debajo de lo esperado lo que constituye un punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

Competencia cognitiva

El valor obtenido en ICC de 76 (entre 70-86) se sitúa en el percentil 5 y se clasifica como inferior/ Medio bajo con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de competencia cognitiva ofrece una estimación de la eficacia con la que se procesa la información durante el aprendizaje, la resolución de problemas y el razonamiento de nivel superior. El ICC es el resultado de 4 puntuaciones escalares: dígitos (Pe = 7), claves (Pe = 4), span de dibujos (Pe = 9) y búsqueda de símbolos (Pe = 7). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente significativa (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos aunque no para todas las tareas), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES

El análisis comparativo permite analizar si existen diferencias significativas entre diversos pares de índices y pruebas del análisis primario y secundario. Esto es importante porque las diferencias significativas merecen un estudio detallado con independencia de cuál sea la aptitud intelectual general del sujeto.

Comparaciones entre índices primarios

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

ANORMAL: Comprensión verbal < Razonamiento fluido: Implica debilidades en las aptitudes fluidas respecto a las cristalizadas.

ANORMAL: Comprensión verbal < Memoria de trabajo: Implica punto débil en la capacidad de identificar y registrar información en la memoria a corto plazo sobre el uso de estímulos verbales para la resolución de problemas.

ANORMAL: Comprensión verbal < Velocidad de procesamiento: Indica punto debilitado en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto al uso de los estímulos verbales para resolver problemas.

ANORMAL: Visoespacial < Velocidad de procesamiento: Refleja debilidades en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto a la capacidad de comprender y utilizar información visoperceptiva/visoespacial.

ANORMAL: Razonamiento fluido < Velocidad de procesamiento: Sugiere capacidades inferiores en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto a las aptitudes para entender la relación entre la información visual y los conceptos abstractos.

ANORMAL: Memoria de trabajo < Velocidad de procesamiento: Establece bajas competencias en la toma de decisiones rápidas utilizando la información registrada en la memoria a corto plazo que en la manipulación de esta información.



Comparaciones entre índices secundarios

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

ANORMAL: Capacidad general < Competencia cognitiva: Indica que las aptitudes que favorecen la eficacia del procesamiento cognitivo (memoria de trabajo y velocidad de procesamiento) pueden ser un punto débil en comparación con las aptitudes cognitivas de nivel superior (comprensión verbal, procesamiento visoespacial y razonamiento fluido).

ANORMAL: Memoria de trabajo < Memoria de trabajo auditiva: Se observó que la presentación verbal de la información establece un nivel inferior en el funcionamiento de la memoria de trabajo respecto a la presentación visual.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS PRUEBAS

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

ANORMAL: Cubos > Puzles visuales: Indica que el aprendizaje procedimental, la resolución de problemas por ensayo-error, el feedback visual concreto y/o la integración visomotora pueden afectar el rendimiento en tareas en las que interviene el razonamiento visoperceptivo y espacial.

ANORMAL: Matrices < Balanzas: Las actividades relacionadas con el razonamiento cuantitativo se establece como punto débil respecto al razonamiento inductivo.

ANORMAL: Claves < Búsqueda de símbolos: Sugiere que el rastreo visual poco efectivo es una fortaleza respecto a la memoria asociativa y/o la velocidad grafomotora.

NORMAL: Balanzas > Aritmética: Designa adecuadas respuestas de aptitud de razonamiento cuantitativo cuando el estímulo y la respuesta son visuales, en vez de verbales.

ANORMAL: Retención de dígitos < Letras y números: Indica respuestas por debajo del promedio con tareas que impliquen de ordenar cadenas largas de números.



Evaluación Neuropsicológica

Atención y funciones ejecutivas

ESCALA DE MEMORIA DE WECHSLER PARA NIÑOS		
ORIENTACIÓN		
SUB-PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
INFORMACION	4/3,8	[NORMAL]
ORIENTACION	4/4.5	[NORMAL]
Mide la orientación alopsíquica y autopsíquicas, si existe alteración en los dos procesos existe alteración global de la orientación.		
MEMORIA DE TRABAJO		
CONTROL MENTAL	9/6.2	SD 1.90 – SD [NORMAL]
Se relaciona con los procesos de la memoria de trabajo, operaciones mentales en línea a corto plazo, memoria semántica, velocidad de respuesta manteniendo la atención sin interferencia.		
DIGITOS	6	8,5 [ANORMAL]
Establece medida de los procesos atencionales que requieren esfuerzo cognitivo, memoria de trabajo, memoria inmediata, indicando habilidades de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad cognitiva, span verbal y auditivo.		

ATENCIÓN		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT A	Puntuación: 24/24 Tiempo: 140/28,99	[NORMAL] [ANORMAL] SD 12,74
Evalúa las habilidades motoras, viso-espaciales de búsqueda visual y atención sostenida.		
ATENCIÓN EJECUTIVA		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TMT B	Puntuación: 0/24 Tiempo: 60/49,81	[ANORMAL] [ANORMAL] SD 29,35
Mide la velocidad de procesamiento, rastreo visual, atención alternante, división, sostenida, flexibilidad mental del pensamiento, habilidades visoespaciales.		



TEST DE PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS (Caras)			
MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PUNTUACIÓN D	ENEATIPO
Aciertos	A	26	7
Errores	E	43	9
Aciertos - Netos	A-N	17	4
Índice de control de impulsividad	ICI	45	2
Evaluación de la atención y de la aptitud para percibir, rápida y correctamente, semejanzas, diferencias y patrones estimulantes parcialmente ordenados.			

FLUIDEZ VERBAL		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS FONOLÓGICO	4/21.0	SD 6,9 [ANORMAL] - SD - 2
Mide la habilidad de producción de palabras que inician con una letra o fonema y el aspecto semántico dentro de una categoría semántica determinada. Evaluación global del lenguaje y funciones ejecutivas, funciones cognitivas.		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
FAS SEMANTICO	12/20.8	SD 4,3 [ANORMAL] - SD - 1
Evalúa la flexibilidad mental, la velocidad de procesamiento y el lenguaje. Pone a prueba los mecanismos necesarios para el acceso al léxico, evocación y denominación.		

FUNCIONES EJECUTIVAS		
TIPO DE PRUEBA	PUNTUACION	INDICADOR
TOKEN TEST	26/33,3	[ANORMAL] SD 1.9 SD - 2
Evalúa la comprensión de ordenes de baja, mediana (dos comandos) y alta complejidad (tres comandos). Comprensión de ordenes con capacidad creciente. Evalúa la comprensión los verbos y las preposiciones incluidos en las instrucciones, sintaxis. Capacidad para comprender el nombre (circulo y cuadrado, color y tamaño).		

TEST STROOP		
Puntuación directa	Puntuación reclasificada	Indicador
25	2	Anormal
Mide el nivel de interferencia generada por los automatismos en la realización de una tarea, valora valorar aspectos como la atención selectiva y de control inhibitorio		



PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE WISCONSIN

Evalúa el razonamiento abstracto, estrategias de solución de problemas necesarias para lograr un objetivo, funciones ejecutivas, cambio de tarea, la flexibilidad cognitiva, la actualización, la inhibición, la planificación o la fluidez, mantenimiento del principio.

Puntuación	Media	indicador
4	4,36	Normal

Normal, pero con perseveraciones y fallas atencionales que le generan problemas para mantener el principio y la atención en la tarea.

WCSTw: Resultados

Indica "nº ítem: tecla pulsada/Acierto(+) o Error(-)/Respuesta según Color, Forma,..."

W.C.S.T. A. Estévez-González, 2001

1: 1/-/FN-/	33: 4/+ /CF-/	65: 1/+ /FN-/	97: 3/-/N-/
2: 1/+ /C-/	34: 3/+ /CF-/	66: 4/+ /N-/	98: 3/+ /CF-/
3: 4/+ /C-/	35: 2/+ /CF-/	67: 2/-/N-/	99: 2/+ /CF-/
4: 1/+ /CN-/	36: 1/+ /F-/	68: 1/+ /CN-/	100: 3/-/C-/p
5: 2/+ /CF-/	37: 4/-/CF-/	69: 2/+ /CF-/	101: 2/-/N-/
6: 3/+ /CF-/	38: 2/-/F-/	70: 3/+ /CF-/	102: 3/-/CN-/
7: 4/+ /CN-/	39: 2/-/C-/p	71: 4/+ /CN-/	103: 1/-/N-/
8: 1/+ /C-/	40: 3/-/F-/	72: 1/+ /C-/	104: 4/-/CN-/
9: 2/+ /C-/	41: 1/+ /CFN/	73: 2/+ /C-/	105: 1/+ /CFN/
10: 3/+ /C-/	42: 4/-/C-/p	74: 2/-/N-/p	106: 4/-/C-/p
11: 4/+ /C-/	43: 4/+ /FN-/	75: 4/+ /C-/	107: 3/-/C-/p
12: 1/+ /CF-/	44: 1/-/F-/	76: 1/+ /CF-/	108: 2/-/CN-/p
13: 4/-/C-/p	45: 2/-/F-/	77: 2/-/N-/p	109: 1/-/C-/p
14: 2/+ /F-/	46: 3/-/CF-/	78: 3/+ /C-/	110: 3/+ /CF-/
15: 1/+ /F-/	47: 1/+ /N-/	79: 2/+ /C-/	111: 4/+ /CF-/
16: 4/+ /CFN/	48: 3/+ /CN-/	80: 4/+ /CFN/	112: 3/-/CN-/
17: 2/+ /FN-/	49: 2/+ /CN-/	81: 1/+ /C-/	113: 3/+ /F-/
18: 3/-/CN-/	50: 3/-/C-/p	82: 3/+ /CN-/	114: 2/+ /F-/
19: 1/+ /CF-/	51: 1/+ /FN-/	83: 1/+ /CF-/	115: 1/+ /FN-/
20: 3/-/C-/p	52: 2/-/CF-/	84: 3/+ /C-/	116: 3/-/N-/
21: 2/+ /FN-/	53: 2/+ /N-/	85: 4/+ /C-/	117: 1/-/C-/p
22: 3/+ /FN-/	54: 4/+ /N-/	86: 2/+ /C-/	118: 4/-/N-/
23: 2/+ /FN-/	55: 3/-/F-/	87: 3/+ /C-/	119: 4/-/C-/p
24: 1/+ /F-/	56: 2/-/C-/p	88: 4/-/C-/	120: 4/+ /F-/
25: 2/+ /F-/	57: 2/+ /N-/	89: 2/+ /F-/	121: 3/+ /F-/
26: 3/-/C-/p	58: 1/+ /FN-/	90: 1/+ /F-/	122: 1/+ /FN-/
27: 3/+ /FN-/	59: 3/+ /FN-/	91: 4/-/C-/p	123: 3/+ /FN-/
28: 4/+ /FN-/	60: 2/+ /CN-/	92: 4/+ /FN-/	124: 2/-/CN-/
29: 2/+ /CFN/	61: 4/+ /CN-/	93: 2/+ /CFN/	125: 2/+ /F-/
30: 3/+ /F-/	62: 3/+ /CFN/	94: 3/+ /F-/	126: 3/+ /CFN/
31: 4/+ /FN-/	63: 2/+ /N-/	95: 2/-/C-/p	127: 1/+ /CF-/
32: 2/+ /CF-/	64: 1/+ /N-/	96: 2/+ /CF-/	128: 2/-/C-/p

Datos Personales

Camilo Enrique Carreño Saucedo
 Fecha : 23/07/25
 Sexo : f
 Edad : 8 años
 Lateralidad : Diestro/a
 Escolaridad : 2 años
 Observaciones no especificadas

Resultados

INTENTOS Utilizados.....: 128
 ACIERTOS Totales.....: 88
 ERRORES Totales.....: 40 (31%)
 Errores Perseverativos...: 19 (14%)
 Errores NoPerseverativos: 21 (16%)
 Respuestas Conceptuales : 72 (56%)
CATEGORIAS.....: 4
 Nº Intentos 1ª categoría: 11
 Errores Manten. del Set : 2
 Aprendiendo a Aprender : -9
 Tiempo medio respuesta : 3630 msec.

Características de la prueba

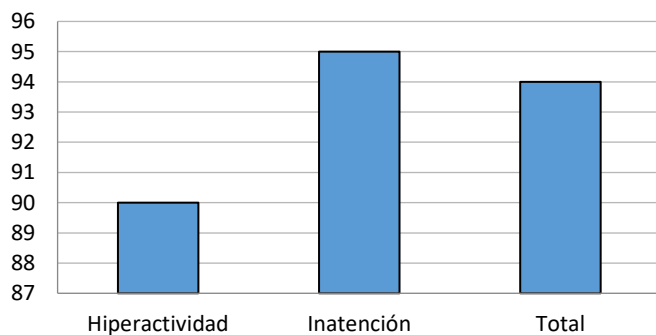
WCST clásico con secuencia CFNO
 Nº Estímulos Prueba : 128

Imprimir Grabar Finalizar

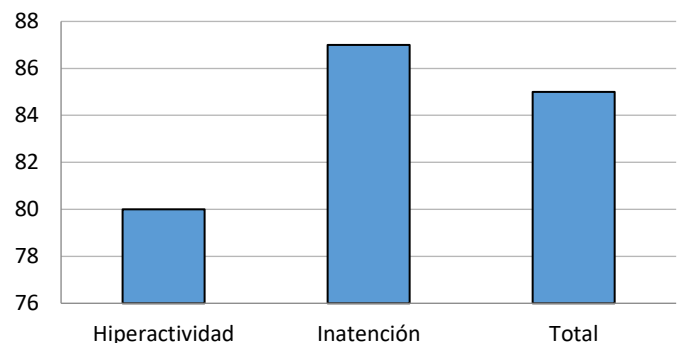
RESULTADOS DEL TDAH 5 HOGAR			
ESCALA	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Hiperactividad	9	90	RIESGO
Inatención	16	95	SIGNIFICATIVO
Total	25	94	SIGNIFICATIVO
DETERIORO		PERCENTIL	CLINICAMENTE
Relaciones con los padres	0	70	NINGUNO
Relaciones con los pares	0	75	NINGUNO
Tareas	1	95	LEVE
Desempeño Académico	1	95	LEVE
Conducta	1	98	LEVE
Autoestima	1	95	LEVE

RESULTADOS DEL TDAH 5 ESCUELA			
ESCALA	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Hiperactividad	6	80	RIESGO
Inatención	17	87	RIESGO
Total	23	85	RIESGO
DETERIORO	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Relaciones con el maestro	1	93	LEVE
Relaciones con los pares	0	60	NINGUNO
Tareas	2	99	MODERADO
Desempeño Académico	2	99	MODERADO
Conducta	1	75	LEVE
Autoestima	2	50	MODERADO

Hogar



Escuela



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESULTADOS DE EVALUACIÓN:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño inadecuado en la atención focalizada, sostenida, selectiva (Inatento) no acorde a su edad y escolaridad.

Presenta inadecuada atención auditiva, inadecuada búsqueda organizada de los estímulos, tardando más de lo esperado en el procesamiento y ejecución de tareas que se deben ejecutar en un tiempo específico.

Paciente con adecuada capacidad de esfuerzo en la ejecución de tareas no motivantes, le cuesta prestar atención a los detalles, se esfuerza y dirige la conducta, le cuesta inhibir los estímulos irrelevantes, le cuesta mantener la concentración cuando el grado de la tarea aumenta, le cuesta regular su comportamiento, le cuesta mantener una adecuada posición sedente, no se observa agitación motora, se observa impulsividad – no hace automonitoreo.

MEMORIA: Presenta inadecuada memoria ecoica con adecuada memoria icónica, la memoria de trabajo presenta un desempeño anormal no acorde a lo esperado para la edad y escolaridad. Esto quiere decir, que existe inadecuada capacidad para mantener una información y dar una respuesta posterior; dependiendo en gran medida del esfuerzo y la motivación para la calidad de las tareas.

Se identifica inadecuada capacidad para evocar información a corto plazo de contenido auditivo verbal lo cual puede afectar el aprendizaje significativo con un total de spam de memoria de 6 sobre 9.

LENGUAJE: Existe inadecuada capacidad de análisis, síntesis, razonamiento complejo a pesar de tener respuestas positivas en la tareas de abstracción, se observa lenguaje reducido, poco espontaneo al momento de las sesiones, baja fluidez fonológica, baja capacidad de conceptualización.

Se observaron problemas articulatorios, no se observa nasalización, hipofonia, parafasias semánticas, fonológicas o visuales.

PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal bajo para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos pero si en las praxias viso construccionales sobre todo por la dificultad de la orientación espacial de los modelos y la verificación de lo que se entrega.



GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS: Paciente con inadecuada regulación conductual, le cuesta realizar procesos de inhibición, inadecuados procesos de análisis e inferencia, adecuadas respuestas de semejanzas, inadecuada fluidez fonológica, adecuada capacidad de cálculo, inadecuada planeación y ejecución de acciones orientadas hacia una meta específica, le adecuado seguimiento de secuencia, le cuesta la organización de la conducta, adecuada capacidad para la generación de estrategias pero con bajas respuestas en los procesos de meta cognición, meta memoria, le cuesta regular la interferencia de estímulos irrelevantes, así como el mantener información en línea mientras ejecuta varias tareas.

Fluides fonológica y semántica: Existe adecuado repertorio semántico pero con baja capacidad de inhibición para responder a categorías fonológicas, es posible la capacidad de planificación y control atencional se relacionen con las bajas respuestas en esta tarea cognitiva.

Paciente con **CIT de 75**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WISC V con **capacidad general intelectual inferior**, dos rangos por debajo del promedio, lo cual establece la necesidad de adecuación y adaptación curricular en las aulas escolares. El CI medio bajo significa que el paciente se tardara más de lo habitual para aprender los conceptos escolares e intelectuales, necesitando más tiempo del habitual a sus pares para obtener aprendizajes significativos, en algunas ocasiones la capacidad cognitiva le puede impedir adquirir aprendizajes de manera significativa.

Las bajas puntuaciones en los indicadores de comprensión verbal, razonamiento perceptivo, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, establecen una marcada dificultad para la adquisición de nuevos aprendizajes y procesos de memoria a largo plazo lo cual puede generar alteraciones en el rendimiento académico e intelectual necesitando supervisión y monitoreo constante para realizar las tareas, especialmente las que demandan mayor esfuerzo cognitivo.

Se observa inadecuado desarrollo de la capacidad cognoscitiva en la comprensión verbal 86 y habilidades visoespaciales de 86, lo cual establece una alteración del desarrollo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto establece la necesidad de estimulación como estrategia que permita un progreso equilibrado de los procesos cognoscitivos.

Se observan respuestas por debajo de promedio en cuanto al procesamiento de la información con sus recursos innatos, del indicador de razonamiento fluido.79, lo que dificulta en el paciente la capacidad de resolver nuevos problemas de forma inmediata, es decir, de forma instintiva y con destreza.

La memoria de trabajo, 85 y velocidad de procesamiento, 75, se encuentran por debajo del promedio, pudiendo generar dificultades en el manejo de la información a corto, plazo, en línea, rápida, efectiva y sin interferencia, lo que puede generar dificultades en la adquisición



del aprendizaje, punto débil normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

Perfil del paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de paciente con perturbación de la actividad y la atención o TDAH de especificidad inatenta y de gravedad moderada, con capacidad intelectual inferior, es posible que su capacidad intelectual sea mejor a la mostrada durante la evaluación neuropsicológica, considerando que se evidenciaron marcados problemas en la memoria ecoica o de procesamiento, fallas atencionales y de verificación de la información, inatención con dificultades para mantenerse atendiendo a los detalles, afectando los indicadores de comprensión verbal, de forma más relevante el vocabulario, baja fluidez verbal acompañada de dislalia – rotacismo, que hace que por momentos se generen bloqueos, fuga de ideas, es decir que la información que responde no se relaciona con el interrogatorio, se evidencio alteración en el indicador de razonamiento visoespacial sobre todo en el desarrollo de praxias viso constructivas, alteración en razonamiento fluido, le cuesta el aprendizaje de forma general aunque tiene mayor desarrollo manipulativo que verbal, por lo que actividades cinestésicas y visuales favorecen el aprendizaje significativo, las respuestas en memoria de trabajo no son consistentes las cuales dependen del grado de atención y motivación en el desarrollo de una tarea específica siempre y cuando esta no requiera de un tiempo específico, la velocidad de procesamiento, se encuentra dos rangos por debajo del promedio esperado con un rendimiento bajo, al igual que el control de impulsividad, con un número de aciertos por debajo de lo esperado, cometiendo errores con tendencia perseverativa, sumado a la baja capacidad viso perceptiva, observándose dificultades para prestar atención a los detalles de los estímulos a realizar los juicios perceptivos o para mantener la atención en una tarea tardando mas de lo esperado en procesar y ejecutar las tareas,

Este nivel intelectual general de 75 y la competencia cognitiva de 76 establecen un perfil característico de paciente con trastorno del aprendizaje no especificado de gravedad moderada, sobre todo para los aprendizajes de contenido auditivo verbal, lo cual se mencionará en este apartado pero no en el eje diagnóstico a espera de un nuevo proceso evaluativo, constituyendo en un fenómeno de objeto de atención clínica ya que puede afectar la dinámica personal, escolar, familiar y social.

COMPRESIÓN VERBAL: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VISOESPACIAL: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

RAZONAMIENTO FLUIDO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

MEMORIA DE TRABAJO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN



IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

F900 PARA *PERTURBACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCIÓN (TDAH de predominio inatento de gravedad moderada)*.

CIT DE 75, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL INFERIOR.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología en tres meses.

Rehabilitación neuropsicológica 2 veces por semanas por seis meses que permita fortalecer los procesos cognitivos de atención sostenida, selectiva, mantenimiento en la tarea, motivación, metacognición, habilidades viso espaciales, fluidez fonológica, aprendizaje, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, aprendizaje, praxias.

Rehabilitación dos veces por semana por seis meses desde psicología que permita abordar seguridad, confianza, tono de voz, organización, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, desarrollo de asertividad; habilidades de afrontamiento; autocontrol y control emocional; (pataletas), entrenamiento en habilidades sociales.

Vincular a los padres mediante psicoeducación y sensibilización, como acompañamiento de la menor en sus dificultades, y orientarla en el manejo de estas.

Realizar actividad física o musical que permita mejorar los procesos de biorritmo y habilidades sociales.

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

Tener en cuenta que algunas respuestas pueden carecer de consistencia sobre todo las que se tratan de definir conceptos.

Permítale recuperar los exámenes con talleres o repitiendo exámenes, en caso de ser necesario.



Organización del espacio y materiales: Mantén tu escritorio ordenado y con los materiales necesarios a mano para evitar distracciones y facilitar el enfoque en las tareas.

Rutinas claras: Sigue una rutina diaria establecida, con instrucciones claras y pasos específicos para cada actividad, lo que ayuda a reducir la confusión y mejorar la atención.

Tiempos de descanso: Toma pequeños descansos entre tareas para recargar la atención. Puedes usar técnicas como la técnica Pomodoro (trabajar 25 minutos y descansar 5).

Tareas cortas y específicas: Divide las tareas grandes en partes más pequeñas y manejables, para que sea más fácil concentrarse en una cosa a la vez.

Uso de apoyos visuales: Utiliza agendas, listas de verificación, esquemas o dibujos para seguir instrucciones y mantenerse enfocado en lo que hay que hacer.

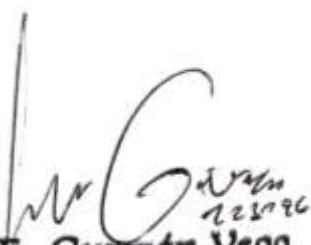
Minimizar distracciones: Busca un lugar tranquilo en el aula, si es posible, y reduce ruidos o estímulos que puedan distraer.

Técnicas de concentración: Practica ejercicios de respiración, mindfulness o atención plena para mejorar la capacidad de mantener la concentración.

Refuerzo positivo: Reconoce y celebra los esfuerzos y logros, por pequeños que sean, para motivar la atención y el interés en las tareas.

Comunicación con docentes: Mantén una comunicación abierta con los maestros para ajustar estrategias y recibir apoyo adicional cuando sea necesario.

Apoyo emocional: Fomenta la confianza y la paciencia, recordándole que mejorar la atención lleva tiempo y esfuerzo, y que está haciendo un buen trabajo.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega
Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.
No. Tarjeta Profesional: 123096

